SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

———

Số: /BVNT-PĐD

V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hộ sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO

Kính gửi: Sở Y tế An Giang (Phòng Nghiệp vụ Y).

Thực hiện Công văn số 8612/SYT-NVY ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Sở Y tế An Giang về việc góp ý dự thảo quy trình kỹ thuật hộ sinh (căn cứ Công văn số 2314/BMTE-SKSS ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Cục Bà mẹ và Trẻ em);

Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân đã giao Phòng Điều dưỡng chủ trì, phối hợp Khoa Sản và đội ngũ hộ sinh nghiên cứu dự thảo tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hộ sinh của Bộ Y tế. Bệnh viện có ý kiến như sau:

I. Ý KIẾN CHUNG

Bệnh viện thống nhất với sự cần thiết ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hộ sinh, làm căn cứ thống nhất thực hành, đào tạo, kiểm tra, đánh giá năng lực hộ sinh và xây dựng quy trình kỹ thuật tại cơ sở. Bệnh viện cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo; đề nghị Ban soạn thảo xem xét các ý kiến dưới đây.

II. GÓP Ý THEO NỘI DUNG SỞ Y TẾ YÊU CẦU

1. Về tính chuẩn hóa

- Đề nghị thống nhất cấu trúc tất cả các quy trình theo một mẫu chung (đại cương, chỉ định, chống chỉ định, chuẩn bị người thực hiện, người bệnh, phương tiện, hồ sơ; các bước tiến hành; theo dõi; tai biến và xử trí; tài liệu tham khảo), giúp cơ sở dễ chuyển thành quy trình nội bộ và bảng kiểm.
- Đề nghị thống nhất thuật ngữ, chữ viết tắt (có bảng chữ viết tắt đầu tài liệu), đơn vị đo, tên thuốc theo tên hoạt chất và liều dùng ghi rõ đường dùng.
- Đề nghị ghi rõ trong mỗi quy trình phần việc hộ sinh thực hiện độc lập và phần việc phối hợp hoặc thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của chức danh hộ sinh theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế.
- Đề nghị mỗi quy trình kèm bảng kiểm đánh giá thực hành (Đạt/Không đạt hoặc thang điểm thống nhất) để các cơ sở dùng chung khi đào tạo, thi tay nghề và giám sát tuân thủ.

2. Về tính khoa học

- Đề nghị cập nhật và trích dẫn rõ nguồn tham chiếu cho từng quy trình, bảo đảm thống nhất với Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện

hành (Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016, Cần xác minh văn bản thay thế nếu có) và các khuyến cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới về chăm sóc trong chuyển dạ.

- Đề nghị thống nhất công cụ theo dõi chuyển dạ (biểu đồ chuyển dạ đang dùng hay công cụ theo dõi chuyển dạ mới) và ghi rõ ngưỡng bất thường cần báo bác sĩ.
- Đề nghị nội dung chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ (da kề da, kẹp cắt rốn muộn, bú mẹ sớm, xử trí tích cực giai đoạn 3) thống nhất với hướng dẫn chuyên môn đã ban hành (Quyết định số 4673/QĐ-BYT năm 2014, Cần xác minh số hiệu, ngày ban hành và hiệu lực).

3. Về mức độ an toàn người bệnh

- Đề nghị bổ sung bước xác định chính xác người bệnh (tối thiểu 02 thông tin nhận diện) trước mỗi kỹ thuật, và nhận diện mẹ - con ngay sau sinh (vòng đeo tay, đối chiếu khi bàn giao).
- Đề nghị mỗi quy trình nêu rõ các dấu hiệu nguy hiểm, ngưỡng phải báo bác sĩ hoặc kích hoạt cấp cứu (băng huyết sau sinh, sản giật, suy thai, ngạt sơ sinh) và phương án xử trí ban đầu của hộ sinh.
- Đề nghị lồng ghép yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn (vệ sinh tay, phương tiện phòng hộ, xử lý dụng cụ, phân loại chất thải) vào từng bước, không chỉ ghi chung ở phần chuẩn bị.
- Đề nghị bổ sung nội dung bàn giao người bệnh giữa các ca, các khoa (phòng sinh, hậu sản, sơ sinh) theo cấu trúc thống nhất, và nội dung ghi chép, báo cáo sự cố y khoa liên quan kỹ thuật hộ sinh.
- Đề nghị bổ sung nội dung tư vấn, giải thích và lấy ý kiến người bệnh trước kỹ thuật; bảo đảm quyền riêng tư khi thăm khám, đỡ đẻ.

4. Về tính khả thi, phù hợp khi triển khai tại địa phương

- Nhân lực: Bệnh viện hiện có 20 hộ sinh (đại học 04, cao đẳng 15, trung cấp 01; số liệu 9 tháng năm 2026). Đề nghị dự thảo ghi rõ yêu cầu trình độ, đào tạo bổ sung hoặc chứng nhận cần có cho từng kỹ thuật (nhất là kỹ thuật mới) để cơ sở có lộ trình đào tạo, phân công phù hợp.
- Phân tuyến kỹ thuật: đề nghị ghi rõ kỹ thuật áp dụng cho từng tuyến (trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa) và điều kiện chuyển tuyến, để trạm y tế và cơ sở tuyến dưới áp dụng đúng phạm vi.
- Trang thiết bị: đề nghị tách danh mục phương tiện tối thiểu bắt buộc và phương tiện khuyến khích; nêu phương án thay thế khi cơ sở chưa có thiết bị (ví dụ monitor sản khoa, máy hút, bộ hồi sức sơ sinh).
- Hồ sơ, biểu mẫu: đề nghị kèm mẫu phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc thống nhất, tương thích hồ sơ bệnh án điện tử, tránh ghi chép trùng lặp làm tăng tải công việc cho hộ sinh.

- Thời gian thực hiện: đề nghị ghi thời gian ước tính cho từng kỹ thuật để cơ sở tính định mức nhân lực, phân ca.

III. GÓP Ý CỤ THỂ VÀO TỪNG QUY TRÌNH

Ghi chú: *Phần này hoàn thiện sau khi Phòng Điều dưỡng nhận tệp dự thảo kèm công văn (tệp 4285284.zip). Các dòng dưới đây là mẫu, thay bằng nội dung thật hoặc ghi "Thống nhất với dự thảo" nếu không có ý kiến.*

TT	Quy trình, trang, mục	Nội dung dự thảo	Nội dung đề nghị sửa, bổ sung	Lý do
1	[Cần bổ sung]			
2	[Cần bổ sung]			
3	[Cần bổ sung]			

IV. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Bộ Y tế tổ chức tập huấn chuyển giao tài liệu sau khi ban hành, kèm bộ bảng kiểm và video kỹ thuật mẫu.
- Đề nghị cho phép cơ sở xây dựng quy trình nội bộ chi tiết hơn trên cơ sở tài liệu hướng dẫn, phù hợp điều kiện nhân lực, trang thiết bị thực tế.

Trên đây là ý kiến góp ý của Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân đối với dự thảo Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hộ sinh (kèm tệp dữ liệu điện tử). Kính gửi Sở Y tế tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Khoa Sản;
- Lưu: VT, PĐD.

GIÁM ĐỐC

Người soạn thảo: CKIĐD. Võ Hồng Thái - Phòng Điều dưỡng